

# RGO (Reflux gastro-œsophagien)

## 1 Définition

Le RGO est la **réurgitation** du contenu acide de l'estomac dans l'œsophage.

Il provoque :

- ✓ brûlures rétro-sternales
- ✓ douleurs après les repas
- ✓ remontées acides, éructations, parfois toux ou hoquet

Il peut évoluer vers :

- ✓ œsophagite peptique
- ✓ endobrachy-œsophage
- ✓ cancer de l'œsophage

---

## 2 Diagnostic allopathique

### Outils médicaux

Diagnostic clinique

Fibroscopie si symptômes persistants

En cas de hernie hiatale : radiographie / fibroscopie

### Traitement médical

Objectif : diminuer l'acidité et protéger la muqueuse

1<sup>re</sup> intention : pansement gastrique = Gaviscon, mesures hygiéno-diététiques

2<sup>e</sup> intention : IPP (Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole etc.)

**En cas d'échec : chirurgie anti-reflux / creation d'une valve entre œsophage et estomac.**

 Les IPP soulagent mais aggravent l'hypochlorhydrie à long terme.

---

## 3 Lecture naturopathique du RGO

**Dans le cours, le RGO est rarement dû à un excès d'acide.**

Il est surtout lié à :

- ✓ hypochlorhydrie si manque CAUSE ÂGE OU STRESS (orthosympathique ++)  
= HPY(helicobacterpilori) = dysbiose putrefaction lie a une mauvaise digestion des PROTEINES liée au manque d'acide chloridrique( gaz odorants symptômes) = carence en fer et B12
- ✓ défaut de mastication
- ✓ insuffisance enzymatique ou biliaire
- ✓ hernie hiatale
- ✓ parfois hyperchlorhydrie (plus rare – parasympathique ++ le corps ouvre toutes les vannes = diarrhees et beaucoup de secretion = ALTÉRATION DU MUCUS
- ✓ HYPHTHYROIDIE ( moins de secretion), ÂGE, ORTHOSYMPATIQUE ++

- ✓ STRESS CHRONIQUE qui impact les organes = surrénales/ foie surcharge /thyroïde/ colon / intestin et production de neurotransmetteurs.

Le reflux est souvent un problème de digestion, pas d'acidité.

#### 4 Enquête clinique (questions à poser)

Questions exactes du support :

- « Prenez-vous le temps de manger ? »
- « Faites-vous un lien entre vos symptômes et une situation de stress ? »
- « Avez-vous des sensations de brûlure dans l'estomac ou uniquement du reflux ? »
- « Avez-vous réalisé une fibroscopie ? »
- « Votre médecin vous a-t-il prescrit un traitement pour votre reflux (IPP) ? »
- « Vos symptômes se déclenchent-ils avec certains aliments (alcool, café, piment, FODMAPs) ? »
- « Le reflux survient-il plutôt avant ou après le repas ? »

### **Comment évaluer si le consultant est en hypochlorhydrie ou hyperchlorhydrie?estomac vide et sans traitement**

Faire le test du bicarbonate de soude /Faire le test au lever, l'estomac vide.

Dissoudre 1/4 de c-à-café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau

Boire et démarrer un chronomètre : Arrêter à la première éructation et noter le temps écoulé.

#### **Bicarbonate + HCL (estomac) = CO<sub>2</sub>**

Au plus on a d'HCL, plus on l'éructation est puissante et arrive rapidement.

Avant 1 min : Hyperchlorhydrie

Entre 1 et 2 min : Pas de déséquilibre

Après 2 min : Hypochlorhydrie probable

**Après 5 min : Hypochlorhydrie quasi certaine**

---

## 5 🐛 Liens entre les systèmes

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Déséquilibre              | Conséquence                           |
| Défaut de mastication     | Fermentations                         |
| Hypochlorhydrie           | Dysbiose putréfactive, carence Fe/B12 |
| Insuffisance enzymes/bile | Stéatorrhée                           |
| Stress chronique          | Orthosympathique ↑                    |
| Hypothyroïdie             | Digestion lente                       |
| Hyperchlorhydrie          | Mucus gastrique altéré                |

## 6 📊 Bilans spécialisés

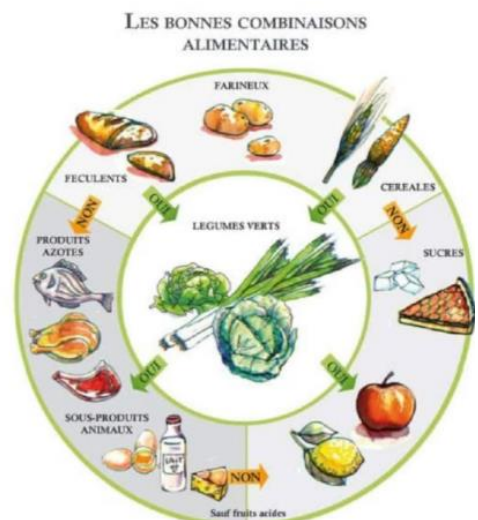
|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Bilan            | Pourquoi                   |
| FUT-2            | Qualité du mucus gastrique |
| Acides biliaires | Qualité de la bile         |
| Test bicarbonate | Hypo ou hyperchlorhydrie   |
| Coproscreen      | Enzymes digestives         |

## 7 🌿 Stratégie naturopathique

### 1. Si alimentation & mastication

- ✓ Manger lentement
- ✓ Éviter manger tard
- ✓ Surélever la tête la nuit
- ✓ Régime dissocie ou FODMAPS (voir tableau)

|                                 | Pauvre en FODMAP                                                                                                                         | Riches en FODMAP                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viande, volaille, poisson, œufs | Bœuf, poulet, thon en conserve, œufs, poisson, agneau, porc, crustacés, dinde, viande froide                                             | Plats cuisinés avec des ingrédients riches en FODMAP ou en sirop de maïs à haute teneur en fructose                                                                                                        |
| Laitages                        | Lait et yaourts sans lactose, beurre, fromages à pâte dure, brie, camembert                                                              | Lait de vache, de brebis, de chèvre, yaourts, crème anglaise, crèmes glacées, fromage blanc... Chocolat, fromages à pâte molle                                                                             |
| Céréales                        | Avoine, épeautre, riz, tapioca, quinoa, maïs                                                                                             | Produits à base de blé et de seigle                                                                                                                                                                        |
| Fruits                          | Banane, baies, raisin, kiwi, fraise, kumquat, citron, mandarine, clémentine, orange, fruit de la passion, ananas, rhubarbe, melon        | Pomme, abricot, date, cerise, framboise, goyave, lychee, mangue, nectarine, pêche, poire, figue, prune, kaki, pastèque, fruits en conserve, fruits secs                                                    |
| Légumes                         | Poivron, aubergine, concombre, carotte, céleri, maïs, laitue, haricot vert, pomme de terre, tomate, courgette, olive                     | Artichaut, avocat, asperge, betterave, poireau, brocoli, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, fenouil, céleri, champignon, pois mange tout                                                                 |
| Boissons                        | Café, thé, jus de fruits pauvres en FODMAP                                                                                               | Boissons à base de sirop de maïs à haute teneur en fructose, jus de fruits riches en FODMAP, vins fortifiés (sherry, marsala...)                                                                           |
| Assaisonnements et condiments   | La plupart des épices et herbes, bouillon fait maison, ciboulette, ail, huile d'olive, vinaigre, vinaigre balsamique, poivre, sel, sucre | Ail, oignons, miel, confiture, gélatine, cacao en poudre, produits à base de légumes ou fruits à haute teneur en FODMAP, chutneys, édulcorants artificiels : sorbitol, mannitol, isomalt, xylitol, inuline |
| Noix et graines                 | Amande (en petite quantité), graine de potiron                                                                                           | Noix de cajou, pistache                                                                                                                                                                                    |



### 2. Si stress

Respiration, relaxation, cohérence cardiaque

### 3. Si déminéralisation

Algues, herbes aromatiques, Plasma de Quinton

### 4. Si hypochlorhydrie (le plus fréquent) on va augmenter la secretion HCL

Ne pas boire pendant les repas, ATTENTION IPP favorise hypochlorhydrie car inhibite la sécrétion acide chloridrique.

**Si pas sous IPP : supplément HCl mais attention pas si ulcère gastrique**  
/Comprendre la cause (âge, stress, thyroïde...)

### 5. Si hyperchlorhydrie (douleur avant les repas)

Bourgeon de figuier

Argile attention si constipation

Jus d'aloe vera entre repas

Jus de pomme de terre crue

6. **Si manque d'enzymes ou bile** analyse type COPROSCREEN laboratoire barbier  
attention coûteux

Plantes amères (artichaut, gentiane, radis noir)

Enzymes digestives = Enzymarel / **Engygest** / Enzymes labo bio Phenix

### 8 ⚠ Interactions importantes

| Situation      | Règle                      |
|----------------|----------------------------|
| IPP            | Favorisent hypochlorhydrie |
| HCl            | ⛔ contre-indiqué si ulcère |
| Plantes amères | ⚠ prudence si calculs      |
| Stress         | Aggrave reflux             |
| Dysbiose       | Empêche la guérison        |

Différences entre RGO – Gastrite chronique – Hernie hiatale

| Critère              | RGO (Reflux gastro-œsophagien)                           | Gastrite chronique (inflammation)                                 | Hernie hiatale (Poche)                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nature               | Trouble fonctionnel                                      | Maladie inflammatoire                                             | Anomalie anatomique                                   |
| Définition           | Remontée du contenu acide de l'estomac dans l'œsophage   | Inflammation de la muqueuse de l'estomac                          | Une partie de l'estomac passe au-dessus du diaphragme |
| Ce qui est malade    | Le sphincter œsophagien et la dynamique de pression      | La paroi gastrique                                                | La position de l'estomac                              |
| Organe atteint       | Œsophage                                                 | Estomac                                                           | Diaphragme + estomac                                  |
| Symptômes principaux | Brûlures rétro-sternales, remontées acides, toux, hoquet | Douleurs au creux de l'estomac, brûlures, intolérance alimentaire | Souvent aucun ou symptômes de RGO                     |

|                        |                                                              |                                                     |                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Douleur                | Derrière le sternum                                          | Dans l'estomac                                      | Variable                                        |
| Moment des symptômes   | Surtout après les repas ou en position allongée              | Pendant la digestion, parfois à jeun                | Variable                                        |
| Lien avec l'acidité    | L'acide remonte (souvent pas trop acide mais mal positionné) | L'acide attaque une muqueuse fragilisée             | Pas un problème d'acide, mais de position       |
| Causes principales     | Hypochlorhydrie, stress, fermentation, enzymes, bile, hernie | Helicobacter pylori, AINS, alcool, tabac, irritants | Obésité, vieillissement, relâchement tissulaire |
| Rôle du stress         | Très important                                               | Important                                           | Indirect                                        |
| Risque principal       | Oesophagite, Barrett, cancer oesophage                       | Ulcère, cancer gastrique                            | Aggrave le RGO                                  |
| Examen médical         | Fibroscopie                                                  | Fibroscopie + test HPylori                          | Fibroscopie, imagerie                           |
| Traitement médical     | IPP, pansements gastriques, parfois chirurgie                | IPP + antibiotiques si HPylori                      | IPP si reflux, chirurgie si sévère              |
| Lecture naturopathique | Problème de digestion et pression                            | Problème de muqueuse et infection                   | Problème de structure                           |
| Lien entre eux         | Peut être causé ou aggravé par hernie                        | Peut être aggravée par RGO                          | Favorise le RGO                                 |

## Résumé clé

RGO            Le contenu remonte  
 Gastrite        La paroi est abîmée  
 Hernie hiatale L'estomac est mal placé

👉 La hernie favorise le RGO

👉 Le RGO agresse la muqueuse → gastrite

👉 La gastrite rend le RGO plus douloureux

## 🔥 LES CAUSES / RGO – Gastrite chronique – Hernie hiatale

| Critère                                 | RGO (Reflux gastro-œsophagien)                         | Gastrite chronique                         | Hernie hiatale                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nature                                  | Trouble fonctionnel digestif                           | Inflammation de la muqueuse gastrique      | Anomalie anatomique                       |
| Définition                              | Remontée du contenu acide de l'estomac dans l'œsophage | Inflammation de l'estomac                  | L'estomac remonte au-dessus du diaphragme |
| Ce qui est en cause                     | Pression + digestion + sphincter                       | Paroi gastrique abîmée                     | Position de l'estomac                     |
| Symptômes typiques                      | Brûlures rétro-sternales, remontées, éructations, toux | Brûlures d'estomac, douleurs épigastriques | Souvent RGO                               |
| Causes principales                      | • Hypochlorhydrie                                      |                                            |                                           |
| • Hyperchlorhydrie                      | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Stress chronique                      | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Défaut de mastication                 | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Insuffisance enzymatique              | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Bile de mauvaise qualité              | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Dysbiose fermentative ou putréfactive | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Hernie hiatale                        | • Helicobacter pylori                                  |                                            |                                           |
| • AINS                                  |                                                        |                                            |                                           |
| • Alcool, tabac                         | OUI                                                    |                                            |                                           |
| • Épices, chocolat                      |                                                        |                                            |                                           |
| • Médicaments (bêtabloquants)           | • Obésité                                              |                                            |                                           |
| • Vieillesse                            | Terrain déminéraliser                                  |                                            |                                           |
| • Relâchement tissulaire                | OUI                                                    |                                            |                                           |
| Mécanisme                               | Mauvaise digestion → gaz → pression → reflux           | Muqueuse fragilisée → brûlures             | Sphincter déplacé → reflux                |
| Lien entre eux                          | Peut être provoqué par hernie ou dysbiose              | Peut être aggravée par RGO                 | Favorise le RGO                           |
| Approche médicale                       | IPP, pansements, chirurgie                             | IPP ± antibiotiques                        | IPP ou chirurgie                          |

|                        |                                                       |                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Lecture naturopathique | Problème de digestion, acidité, enzymes, bile, stress | Problème d'infection et de muqueuse | Problème structurel |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

---

## Le point clé à retenir

👉 Le RGO n'est pas une maladie d'acidité  
C'est une maladie de mauvaise digestion + pression interne.

C'est pour cela que :  
les IPP soulagent  
mais ne guérissent pas  
et peuvent même aggraver l'hypochlorhydrie à long terme.

---